

# Informe del Registro de Glomerulopatías (Julio 2021) Sociedad Uruguaya de Nefrología



## **Introducción:**

La incidencia de las glomerulopatías (GP) tiene amplias variaciones probablemente vinculadas a variaciones de la incidencia real de las diferentes patologías, aunque también dependientes del acceso a la biopsia renal y a las diferentes técnicas diagnósticas, de las prácticas nefrológicas, de las variaciones socioculturales y económicas. Existen amplias diferencias en la incidencia de las glomerulopatías (GP) en el mundo, probablemente vinculadas a factores genéticos y ambientales, aunque también dependientes de las prácticas nefrológicas locales y medio socioeconómico lo que condiciona el acceso a la biopsia renal y técnicas diagnósticas.

El Programa de Prevención y Tratamiento de las Glomerulopatías tiene entre sus objetivos la descripción de la incidencia de las diversas glomerulopatías y su forma de presentación, para poder comunicar dichas variaciones a la comunidad nefrológica, los prestadores de salud y las autoridades.

Nuestro país tiene como características la facilidad de desplazamiento en el territorio, la accesibilidad a los servicios de salud, la existencia de un pequeño número de Patólogos dedicados a la patología renal, al igual que una fuerte adherencia de la comunidad nefrológica nacional al Programa, lo que nos permite conocer la totalidad de las biopsias renales realizadas en el país en un período de tiempo.

## **Objetivo:**

En esta comunicación se continúa la serie de informes del Registro Uruguayo de Glomerulopatías (RUG) iniciada en el 2010 e incluyendo los datos de 2008 en adelante, referentes a la primera biopsia de riñón nativo. En este caso, se actualiza la información referente al año 2019 y se compara con la de 2020, año en que por la particularidad de la epidemia de COVID19 y a consecuencia de las medidas adoptadas para enfrentar la misma, podría haber diferencias sustanciales con años anteriores.

## **Metodología:**

Se recolectaron los datos de biopsias de los laboratorios de Anatomía Patológica que concentran las biopsias renales no oncológicas. Los datos clínicos fueron solicitados a los nefrólogos tratantes y/o relevados por el patólogo al momento de la biopsia. La información a recabar por esta vía está aún incompleta, dado el breve lapso transcurrido desde la realización de la biopsia hasta la elaboración del informe. Completar los datos clínicos de cada paciente es un proceso largo y laborioso que involucra la colaboración honoraria y desinteresada de los nefrólogos que deben dedicar parte de su tiempo libre a completar los datos solicitados.

Se calculó la frecuencia de PBR y glomerulopatías por millón de población para mayores de 14 años. Para el cálculo de tasas se estimó la población general mediante interpolación lineal a partir de los datos censales de 2004 y 2011. (Fuente: INE) De esta forma, la población mayor total del país se estimó en 3.338.098 en 2019 y 3.344.571 en 2020; los mayores de 14 años se estimaron en 2.691.501 en 2019 y 2.706.574 en 2020.

Los diagnósticos considerados fueron la lesión glomerular mínima (LGM), la glomeruloesclerosis segmentaria y focal (GESF), la glomerulopatía membranosa (GMEM), la glomerulopatía membranoproliferativa, la nefropatía a IgA (NIgA), lupus, vasculitis, mieloma, amiloidosis y microangiopatía trombótica.

Algunas GP se agruparon para su análisis: las vasculitis incluyen: vasculitis pauciinmune ANCA negativa, MPO, PR3 y sin clasificar, glomerulonefritis proliferativa intra y extracapilar y glomerulopatía por crioglobulinas. Para este análisis las formas de IgA limitada al riñón y la vasculitis IgA se agruparon como NIgA (incluye síndrome de Schönlein Henoch).

Se analizó sexo, edad y forma de presentación de la enfermedad. La forma de presentación procede del reporte de los nefrólogos codificadas según las definiciones del programa de Prevención y tratamiento de las glomerulopatías (PPTG) o de la información con la que cuentan los patólogos al momento de la biopsia renal.

## **Resultados**

En el período 2019-2020 se realizaron 467 primeras biopsias en riñones nativos (294 en 2019 y 163 en 2020) lo que corresponde a una tasa de biopsia de 69.9 por millón de población (pmp). Es de destacar la diferencia en las tasas de biopsia entre ambos años que resulta de 88.1 casos pmp en 2019 y 51.7 en 2020.

Correspondieron a GP 397 estudios (249 en 2019 y 148 en 2020), arrojando una tasa de incidencia de GP de 59.4 pmp (72.5 en 2019 y 44.3 en 2020). La edad de los pacientes cuyas biopsias correspondieron a GP fue de 2 a 86 años, con una media de 44 años (Desvío estándar: 20.8).

### **Glomerulopatías en pacientes mayores de 14 años**

Del total de GP registradas en el bienio 2019-2020, 362 correspondían a mayores de 14 años (220 en 2019 y 142 en 2020). La incidencia anual por millón de población (pmp) en mayores de 14 años fue de 67.1 pmp en este bienio (81.7 en 2019 y 52.5 en 2020)

El 49.7% de los pacientes eran hombres y el 50% mujeres (sin registro de sexo en 1 paciente). La media de edad entre los mayores de 14 años fue 46.7 años. La tabla 1 muestra la distribución por grupos etarios de los pacientes, discriminados por año de realización del estudio.

El diagnóstico más frecuente en las biopsias correspondientes a glomerulopatías fue la Glomeruloesclerosis focal y segmentaria (22.47% de los casos), seguida de la nefropatía IgA (14.4%), como se muestra en la tabla 2.

**Tabla 1. Edad al momento de la biopsia en el período 2019-2020 (Mayores de 14 años)**

|          | 2019                  |        | 2020                  |        | Total                 |        |
|----------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|          | Cantidad de pacientes | %      | Cantidad de pacientes | %      | Cantidad de pacientes | %      |
| 15-24    | 44                    | 20.1%  | 15                    | 10.6%  | 59                    | 16.3%  |
| 25-34    | 34                    | 15.5%  | 21                    | 14.8%  | 55                    | 15.2%  |
| 35-44    | 28                    | 12.8%  | 20                    | 14.1%  | 48                    | 13.3%  |
| 45-54    | 31                    | 14.2%  | 26                    | 18.3%  | 57                    | 15.8%  |
| 55-64    | 36                    | 16.4%  | 25                    | 17.6%  | 61                    | 16.9%  |
| 65-74    | 34                    | 15.5%  | 23                    | 16.2%  | 57                    | 15.8%  |
| 75-84    | 9                     | 4.1%   | 12                    | 8.5%   | 21                    | 5.8%   |
| 85 y más | 3                     | 1.4%   | 0                     |        | 3                     | .8%    |
| Total    | 219*                  | 100.0% | 142                   | 100.0% | 59                    | 100.0% |

\* Sin dato de edad en un paciente

**Tabla 2: Frecuencia de glomerulopatías biopsiadas en mayores de 14 años.  
Período 2019-2020**

| Diagnóstico                             | Frec. absoluta | Porcentaje   |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| LGM                                     | 18             | 5.0          |
| Glomeruloesclerosis focal y segmentaria | 81             | 22.4         |
| Nefropatía membranosa                   | 34             | 9.4          |
| GN membranoproliferativa                | 21             | 5.8          |
| GN IgA                                  | 52             | 14.4         |
| Lupus                                   | 47             | 13.0         |
| Diabetes                                | 16             | 4.4          |
| Vasculitis                              | 36             | 9.9          |
| Amiloidosis                             | 8              | 2.2          |
| Microangipatía trombótica               | 12             | 3.3          |
| Otras                                   | 2              | 0.6          |
| Inclasificable                          | 27             | 7.5          |
| <b>Total</b>                            | <b>362</b>     | <b>100.0</b> |

**Conclusiones:**

El presente informe confirma que, durante 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID19 existió un descenso significativo del número de biopsias renales en el país. El análisis del bienio 2020-2021 y su incorporación a las series temporales bianuales de los informes posteriores dará un panorama más acabado de las consecuencias de la pandemia sobre el diagnóstico de la enfermedad glomerular.